Mulumeoderhwa et al., 2025 *Rev. Cent. Rech. Pour Promot. Santé, 8(2) : 105-118*
DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17361412

Revue du Centre de Recherche pour la Promotion de la Santé

Journal homepage : https://istmbukavu.org/crps.php eISSN : Xxxx-Yyyy

RESEARCH ARTICLE **Open Access**

Développement de la région de grands lacs : Analyse sur la réduction des violences sexuelles et basées sur le genre par l'approche psychosociale communautaire « Guérir Ensemble » (Cas de la province du Sud-Kivu à l'Est de la République Démocratique du Congo)

Mulumeoderhwa Bukwanane A[1,2,3*], Aziza Aziz-Suleyman A[2,4,5], Kamuzinzi Masengesho[6], Gasibirege Simon[6], Bagendabanga Macece E[1,2,7], Rouamba Ouédraogo V[4,8], Maheshe Musole T[14], Nabintu Bisimwa V[9], Baciyunjuze Jean Baptiste[9], Birindwa Zagabe P[10], Kanumba Alexi[10], Cigerano Mulangala D[11], Ndokabilya Dunia E[1,2,5], Barahiga Nsimire B[12], Munyanga Mukungo S[12,13]

[1]Filière de Santé Communautaire, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM-Bukavu, Sud-Kivu en République Démocratique du Congo.
[2]Faculté des Sciences Sociales, Université Catholique de Bukavu en République Démocratique du Congo.
[3]Centre de Recherche pour la Promotion de la Santé, CRPS/ISTM-Bukavu.
[4]Genre et développement, Institut de Hautes Etudes de la Suisse.
[5]Direction de Développement et de Coopération de la Suisse.
[6]Faculté des Sciences Sociales et Gouvernance, Université Nationale du Rwanda.
[7]Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Officielle de Bukavu en R.D. Congo.
[8]Laboratoire de Genre et Développement, Université Joseph Kizerbo du Burkina-Faso.
[9]Réseaux des Femmes pour les Droits et la Paix.
[10]Centre Psychiatrique SOSAME-Sud-Kivu en République Démocratique du Congo.
[11]Coordination Provinciale de Santé Mentale du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo.
[12]Faculté de Médecine, Université de Kinshasa en République Démocratique du Congo.
[13]Ecole de Santé Publique, Université de Goma, Nord-Kivu en République Démocratique du Congo.
[14]Faculté de Droit, Université Catholique de Bukavu, Sud-Kivu en République Démocratique du Congo.

ARTICLE INFO

***Corresponding Author*:** Mulumeoderhwa Bukwanane A; *E-mail:* alainmb04@gmail.com

Received : 18 Jun 2025
Accepted : 16 Sept 2025
Published: 15 Oct 2025

Read online:

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

© 2025 Mulumeoderhwa et al. licensee CRPS. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

RESUME

Introduction : L'Approche Psychosociale Communautaire (APC) « Guérir Ensemble » a été promue par la Coopération Suisse et certaines organisations partenaires. Elle a pour but de faire renaître la solidarité, l'entraide et la participation communautaire pour lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre. **Objectif :** Cette étude analyse le changement à travers certains facteurs de développement (psychologique, social, économique…) chez les bénéficiaires directs à l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC). **Matériels et méthodes :** Elle a eu recours à des techniques qualitatives et quantitatives pour appréhender en profondeur le changement observé (focus group, interview et récit de vie) et par la suite, il s'agissait de compléter ces résultats en mesurant objectivement les indicateurs de changement ou de développement à chaque niveau chez les bénéficiaires dans les sites d'étude (territoire de Walungu). Les données ont été traitées et analysées à l'aide des logiciels Excel 2013, Epi Info 3.5.4. et QDA Miner. **Résultats :** Les résultats ont montré que les violences ont toujours existé, mais la situation s'est accentuée avec la présence des groupes armés et des rebelles depuis les années 1994 et 1996. Il existe également certaines pratiques culturelles rétrogrades, en plus des causes liées à l'insécurité. Le manque de collaboration, les bagarres, les tortures, la justice populaire, les mariages forcés et précoces, la discrimination des femmes, le viol des filles et des femmes… constituent les manifestations des violences dans la communauté. Les femmes et les jeunes filles restent la catégorie la plus vulnérable. Ces traumatismes ont déclenché chez la victime l'esprit de vengeance, de honte, de solitude, le sentiment d'infériorité, d'isolement, le recours à la justice populaire et la culpabilité. Les membres intègrent les ateliers de l'approche « guérir en semble » par la sensibilisation. Le changement s'observe ; la guérison des blessures intérieures, la disparition de l'esprit de vengeance, de solitude, de conflit. Le travail en équipe (homme-femme), le développement socio-économique individuel, familial et communautaire ont été appréhendé. Les bénéficiaires sont engagés à animer les ateliers mais suggèrent une formation des personnes-ressources et un appui économique. De plus, une grande partie a déjà commencé à sensibiliser d'autres membres (soit 87,2 %). La majorité participe aux travaux en équipe (soit 96,4 %). La majorité est également déjà ouverte à la collaboration intercommunautaire (soit 92,4 %). **Conclusion :** Cette étude montre les effets transformateurs

de cette approche « Guérir Ensemble » et met en évidence le changement à travers les facteurs de développement qui ont concouru à la réduction des violences. Il y a urgence à pérenniser et à consolider les acquis en passant par son institutionnalisation et le renforcement des activités y relatives au sein des communautés et des institutions de l'État.

Mots-clés : Développement, approche psychosociale communautaire, violences sexuelles et basées sur le genre, région des Grands Lacs.

Development of the Great Lakes Region: Analysis on the Reduction of Sexual and Gender-Based Violence through the Community Psychosocial Approach 'Healing Together' (Case of South Kivu province in Eastern Democratic Republic of Congo)

ABSTRACT

Introduction: The Community Psychosocial Approach (CPA) *"Healing Together"* was promoted by the Swiss Cooperation and some partner organizations. Its purpose is to revive solidarity, mutual support, and community participation to combat sexual and gender-based violence (SGBV). **Objective:** This study analyzes change through certain development factors (psychological, social, economic…) among direct beneficiaries in Eastern Democratic Republic of Congo (DRC). **Materials and Methods:** The study used both qualitative and quantitative techniques to deeply capture the observed change (focus groups, interviews, and life stories). These findings were then complemented by objectively measuring change or development indicators at each level among beneficiaries in the study sites (Walungu territory). Data were processed and analyzed using Excel 2013, Epi Info 3.5.4, and QDA Miner. **Results:** The findings showed that violence has always existed, but the situation worsened with the presence of armed groups and rebels since 1994 and 1996. In addition to insecurity-related causes, there are also retrograde cultural practices. Lack of collaboration, fights, torture, mob justice, forced and early marriages, discrimination against women, rape of girls and women… constitute manifestations of violence within the community. Women and young girls remain the most vulnerable group. These traumas triggered in victims feelings of revenge, shame, loneliness, inferiority, isolation, recourse to mob justice, and guilt. Community members join *"Healing Together"* workshops through awareness sessions. Change is observed: healing of inner wounds, disappearance of feelings of revenge, loneliness, and conflict. Teamwork (between men and women), individual, family, and community socio-economic development were also achieved. Beneficiaries are engaged in facilitating workshops but suggest training of resource persons and economic support. Moreover, a large proportion has already begun raising awareness among others (87.2%). The majority participates in teamwork activities (96.4%). Most are also already open to inter-community collaboration (92.4%). **Conclusion:** This study highlights the transformative effects of the *"Healing Together"* approach and demonstrates change through development factors that contributed to reducing violence. There is an urgent need to sustain and consolidate these gains through institutionalization and reinforcement of related activities within communities and state institutions.

Keywords: Development, community psychosocial approach, sexual and gender-based violence, Great Lakes region.

1. Introduction

La violence est l'une des violations des droits fondamentaux les plus fréquentes dans le monde. Elle ne connaît pas de frontières, qu'elles soient économiques, sociales ou géographiques [1]. Bien que cette situation ait des conséquences sur le développement des communautés, les études et les rapports montrent que les femmes et les filles sont les premières victimes des violences (physiques, sexuelles, psychologiques, verbales, économiques…). Elles sont aussi soumises au quotidien à des violences moins visibles, plus insidieuses, telles que l'accès inégal au marché du travail, l'inégalité des salaires, l'évolution de carrière plus lente, la répartition inégale des tâches domestiques, etc. [2]. La guerre, la violence, l'instabilité et les pratiques culturelles néfastes ont ravagé la République Démocratique du Congo (RDC) pendant des décennies, ce qui a conduit à une culture de la violence en temps de guerre et dans la vie civile, qui prend souvent une forme de nature sexuelle [3].

Le Sud-Kivu est parmi les contrées les plus touchées par les violences et cette situation a entraîné plusieurs conséquences touchant la société entière et la femme en particulier. Dans les zones les plus touchées, les communautés ont connu plus d'instabilité et des perturbations psychologiques accrues. Cette situation a engendré des symptômes tels que la culpabilité, la solitude, la colère, la dépression et l'esprit de vengeance. Elle a provoqué des troubles comportementaux jusque dans les familles. Les communautés touchées rencontrent de multiples problèmes d'acceptation et d'intégration socioéconomique, les rendant encore plus vulnérables ; elles ont, en outre, perdu la capacité de développer la résilience, la confiance en soi et les compétences de vie [3].

Face à cette problématique, la Coopération suisse a mis en place le programme « Approche Psychosociale Communautaire : Guérir ensemble ». Cette approche prend en compte non seulement

les victimes et/ou les auteurs, mais également leurs communautés et leurs familles. Elle mise sur les ressources collectives d'auto-prise en charge pour transformer les communautés blessées en communautés actives et solidaires. Le traumatisme et toute autre blessure de la vie ne sont pas attribués à des personnes individuellement, mais aux communautés considérées comme des entités actives, dotées de ressources propres et particulièrement efficientes [4,7]. Elle vise donc le développement personnel par le dialogue, en mettant l'accent sur la prise de conscience de soi-même en tant qu'auteur et victime des violences. Elle construit la proximité des partenaires et, par ricochet, avec les enfants et le développement de la communauté.

Cette approche a été mise en œuvre par certaines organisations dans la région des Grands Lacs (RD Congo, Rwanda et Burundi). Les interventions ayant été menées, il est désormais question de procéder à l'évaluation du développement induit par l'Approche Psychosociale Communautaire « Guérir ensemble » chez les bénéficiaires du programme. La présente étude servira d'instrument scientifique de plus sur cette thématique de la réduction des violences. Elle contribuera à l'outil de plaidoyer pour l'institutionnalisation de cette approche. Elle contribuera à mettre en évidence les effets transformateurs de l'approche « Guérir ensemble » dans la réduction des violences, spécifiquement dans le territoire de Walungu, à l'Est de la RDC, dans le site d'intervention de SOSAME.

2. Matériels et méthodes

La méthodologie utilisée dans cette étude tire son ancrage dans l'Approche Psychosociale Communautaire « Guérir ensemble ». Cette approche s'oriente vers une perspective communautaire et non individuelle. Le processus de développement (guérison) passe par 5 étapes ou ateliers (atelier de conscientisation communautaire aux violences sexuelles et domestiques, atelier sur le deuil, atelier sur la gestion communautaire des sentiments associés aux Violences, atelier sur le pardon et la réconciliation et projet de vie). Le développement étant un type de changement lorsqu'il est orienté vers l'amélioration. Le terme développement a donc été utilisé pour parler du changement. Pour évaluer ce développement, la théorie du « Guérir ensemble » se focalise sur 5 niveaux de développement (développement personnel par le dialogue, développement au niveau des foyers, développement économique, développement rayonne dans le voisinage, engagement pour la transformation des autres dans un groupe avec d'autres relais) [7]. Pour appréhender ou explorer d'une manière approfondie le développement des communautés qui ont concouru à la réduction des violences et par la suite mesurer objectivement les indicateurs de développement selon cette approche « Guérir Ensemble », cette étude a fait recours à une approche mixte (qualito-quantitative).

2.1. Approche qualitative

2.1.1. Focus group

Cette méthode reposait sur l'utilisation de groupes de discussion. Un échantillon a été constitué parmi les femmes et les hommes de la communauté bénéficiaire du territoire de Walungu. Les groupes de discussion, composés de 8 à 12 personnes, ont été invités à participer à des échanges interactifs d'une durée moyenne d'une heure et demie. Au total, 8 focus groups ont été réalisés. Les données à analyser ont été recueillies sous forme de transcriptions manuscrites dans un cahier brouillon. Les équipes d'investigation étaient constituées de trois animateurs : deux transcripteurs et un relanceur. Une analyse thématique a ensuite été menée avec le logiciel QDA Miner. Les thèmes qui ont guidé l'entretien sont : l'origine des violences, les manifestations des violences, la gestion de sentiment, les effets des violences sur la vie et le bien-être de la communauté, le contexte et but d'intégration des ateliers, le changement observé, l'appropriation de l'APC, la satisfaction dans les échanges et limites des ateliers, la solution pour consolider les ateliers.

2.1.2. Entretien individuel

Cette méthode consistait à s'entretenir avec les leaders communautaires (chefs de village et du territoire) des bénéficiaires. Ces entretiens visaient à recueillir l'opinion des autorités sur les effets transformateurs de l'Approche Psychosociale Communautaire (APC) dans la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) auprès des bénéficiaires directs. Les autorités ciblées ont été invitées à participer à des entretiens individuels approfondis d'une durée maximale d'une heure. Les données recueillies ont fait l'objet d'une analyse thématique. Les thèmes qui ont guidé cet entretient sont : les problèmes enregistrés dans l'exercice de son travail, le comportement avec l'APC comme réponse aux violences, le soutien et limites de l'APC au niveau de la communauté.

2.1.3. Récit de vie

Cette méthode qualitative a permis d'appréhender le sens des phénomènes humains dans leur temporalité, tels que la construction identitaire individuelle, les trajectoires sociales et les transformations culturelles. Conformément aux principes méthodologiques, les récits de vie ont été structurés autour des étapes suivantes : la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties (événements), l'élément rééquilibrant, la situation finale et l'appropriation de l'approche. Deux personnes ayant déjà complété les ateliers sur le site de SOSAME ont été invités à partager leur vécu. Les discours ont été transcrits dans un cahier brouillon. Une analyse verbatim a ensuite été réalisée.

2.2. Approche quantitative

Cette partie de l'étude est de type transversal et concerne les bénéficiaires directs de l'Approche Psychosociale Communautaire (APC) dans la province du Sud-Kivu, plus précisément dans le territoire de Walungu, site d'intervention de SOSAME. Les participants ciblés étaient les responsables ou les conjoints des chefs de ménages ayant bénéficié des ateliers « Guérir Ensemble ».

L'échantillonnage a été réalisé à plusieurs degrés. La taille de l'échantillon a été calculée à l'aide de la formule de proportion simple, aboutissant à un total de 125 bénéficiaires enquêtés. Dans un premier temps, deux groupements ont été sélectionnés par la méthode d'échantillonnage aléatoire simple. Au second degré, quatre villages ont été tirés au sort selon la même méthode. Dans chaque village, une personne-ressource fournissait aux enquêteurs la liste des participants aux ateliers (base de sondage). La méthode systématique a ensuite été utilisée pour déterminer le pas de sondage et sélectionner les participants à interroger.

La collecte des données s'est effectuée au moyen d'un questionnaire comportant certains paramètres (caractéristiques socio-économique, intégration et sensibilisation, normes culturelle, entraide et solidarité, les développements observées…) administré aux participants, soit lors des ateliers, soit à leur domicile. Les données ont été saisies et analysées à l'aide des logiciels Excel 2013 et Epi Info 3.5.4. Les résultats ont été présentés sous forme de fréquences et de pourcentages.

3. Résultats

3.1. Résultats qualitatifs

3.1.1. Focus group avec les bénéficiaires directs

Les focus group ont été menés au total 8 focus group ont été effectués. Ils prenaient en compte les femmes et les hommes bénéficiaires de l'approche psychosociale communautaire. Ils étaient représentés pour la plupart par des femmes et la majorité était agriculteur ou éleveur avec un niveau d'étude secondaire.

Le tableau 1 reprend les résultats des groupes de discussion effectués avec les bénéficiaires de l'APC « guérir ensemble ».

Tableau 1. Résultats des groupes de discussion effectués avec les bénéficiaires de l'APC

Thèmes	Site de Nzibira (SOSAME)
1. Origine des violences	
1.1. Origine des viols	Existent il y a longtemps, Forte fréquence liée à la présence des rebelles et groupe armé.
2. Manifestation des violences	
2.1. Sexuelle	Viol des femmes et des filles.
2.2. Culturelle	Domination des hommes à l'égard des femmes, Discrimination de la femme, surtout pour de grandes décisions.
2.3. Sociale	- Manque de collaboration, mariage forcé, mariage précoce et le menace de mort. - Enlèvement des femmes par les groupes armés.
2.4. Physique	Torture des personnes et le bagarre.
2.5. Économique	Baisse de revenu de la famille (pauvreté), car il y a incapacité de relancer l'économie de la famille.
2.6. Psychologique	Intimidation.

Tableau 1 : *Suite*

2.7. Verbale	Injures contre les femmes.
2.8. Vie conjugale	Bagarre au sein de couple.
2.9. Cause des violences dans les communautés et dans les familles	Les guerres à répétition, contrôle de ressources minières et les coutumes qui défavorisent les femmes (la femme n'a pas de parole devant les hommes, une bonne femme supporte tout, la femme n'a pas chez elle...)
2.10. Catégorie de personnes touchées	Les femmes et les jeunes filles sont les plus touchées, les enfants orphelins et les pauvres.
2.11. Comportement des auteurs dans la communauté et dans la famille	Intouchables - Arrogance, d'autres se droguent ou se réfugient dans la forêt.
2.12. Justification des violences à l'égard de la femme et de la jeune fille	On pense toujours que l'homme a raison La religion est aussi une justification (donne plus d'importance aux hommes).
3. Gestion de sentiment	
3.1. Comportement et attitude par rapport aux violences vécues.	Se sentir inférieur ou sans valeur, sentiment de vengeance, consolation entre survivantes, peur, frustration et l'isolement.
3.2. Réaction communautaire face aux violences.	Pas de procédure ni de méthode pour gérer ces cas, Appel à la vengeance et la discrimination de la survivante.
3.3. Sentiments qui animent le cœur en cas de violence.	La vengeance familiale et communautaire.
4. Effets des violences sur la vie et le bien-être de la communauté	
4.1. Blessures liées au bien-être.	Séparation totale entre les membres de la famille ou de la communauté et la rupture de collaboration.
4.2. Blessures liées à la stabilité et l'unité familiale.	Rupture du mariage avec son partenaire.
4.3. Blessures affectant la santé mentale.	Recours au suicide - Frustration et la dépression.
4.4. Blessures affectant l'éducation des enfants.	Abandon scolaire des enfants dans les familles.
4.5. Blessures affectant la capacité de prise en charge.	Pensées perturbant toute initiative d'auto-prise en charge à cause de la peur.
4.6. Blessures affectant le travail en synergie au sein de la communauté	Rupture de collaboration avec les membres de la communauté.
4.7. Blessures affectant la gestion de conflits	Les autres c'est l'enfer et on ne peut en aucun cas collaborer avec eux.
4.8. Blessures affectant le développement de la communauté et de la famille.	La pauvreté refait surface, car la femme ne travaille pas.
5. Contexte et but d'intégration des ateliers	
5.1. Contexte d'intégration des ateliers	Sensibilisation par les membres de la communauté et la sensibilisation par les animateurs des ONG.
5.2. But d'intégration des ateliers	Trouver un refuge pour commencer aussi à guérir les blessures internes et être formé sur comment mener une bonne vie.
5.3. Thèmes abordés dans les ateliers	Conscientisation, - Deuil, projet de vie (animé par les personnes - ressources), - Gestion des sentiments - Pardon et réconciliation - Vie future – Auto-prise en charge.
6. Changement observé	
6.1. Reconnaissance du changement	Esprit de vengeance qui disparait, solitude qui disparait et la stabilité.
6.2. Changement relatif au bonheur et au bien-être	Considération par les membres de la communauté et la fierté.
6.3. Changement en rapport à la santé mentale	Se sentir libéré de ses mauvaises pensées, la réduction des violences au sein de famille et recouvrer sa stabilité.
6.4. Changement observé sur l'éducation des enfants	Tous les enfants commencent à étudier sans distinction de sexe, Les enfants étudient par nos propres moyens,
6.5. Changement en rapport avec la capacité de se prendre en charge	Développement de l'esprit entrepreneurial (commerce) ou Activités Génératrice de Revenu.

Tableau 1 : *Suite - fin*

6.6. Changement relatif au travail en synergie, au développement de la communauté et de la famille	Les femmes participent aux travaux qui étaient réservés aux hommes (construction) et vice-versa (champs, ménage...), travail en équipe au sein de la communauté et création d'une caisse commune.
6.7. Changement observé dans la gestion des conflits	Recours à la médiation, réconciliation avec le partenaire ou d'autres membres de la communauté à l'origine du mal, le partage et le pardon.
6.8. Apport des ateliers dans la réduction des violences	Ils nous ont aidés à partager les expériences selon les instructions reçues.
7. Appropriation de l'APC	
7.1. Mécanisme utilisé pour la sensibilisation	Contact avec les autorités pour nous aider à mobiliser les membres, Sensibilisation porte à porte et les jours de travaux communautaires servant aussi à la sensibilisation.
7.2. Activités développées dans le groupe au-delà des ateliers	La mutuelle de solidarité (MUSO) et l'Association Villageoise d'Épargne et de Crédit (AVEC).
7.3. Être en mesure d'animer un atelier	Les ateliers dont nous sommes capables d'animer sont : Atelier sur le pardon et réconciliation, Atelier sur la réconciliation, Atelier sur le projet de vie.
8. Satisfaction dans les échanges et limites des ateliers	
8.1. Satisfaction dans les échanges et limites des ateliers	Bonne organisation des ateliers, Nécessité de former plus des membres, Le renforcement économique des membres du groupe, car la situation économique influence la participation aux ateliers (transport, contribution…).
9. Solution pour consolider les ateliers	
9.1. Solution pour consolider les ateliers	Accompagner les formateurs par le biais d'autres formations, Former et renforcer aussi les membres sur l'élevage, l'agriculture…

SOSAME : Soins de santé mentale ; APC : Approche Psychosociale Communautaire

3.1.2. Interview avec les chefs

Les interviews ont ciblé les autorités politico-administratives (chefs de villages, chefs de groupements et l'administrateur du territoire). Au total 19 interviews ont été menées.

Le tableau 2 reprend les résultats des interviews avec les autorités politico-administratives sur le changement induit par l'APC.

Tableau 2 : Résultats des interviews avec les autorités politico-administratives

Thèmes	Site de Nzibira (SOSAME)
1. Problèmes enregistrés dans l'exercice de son travail	
Problèmes affrontés	Attentat à la pudeur, Abandon conjugal, Attouchement, Coups et blessures, Complicité de vol, Extorsion des biens, Grossesses et mariages précoces, Harcèlement sexuel, Insécurité, Mariage forcé, Menace, Meurtre, Torture, Viol, et Vol à main armée.
2. Comportement avec l'APC comme réponse aux violences	
Changement observé avec l'avènement de l'APC « guérir ensemble »	Diminution des violences au niveau de la famille et la communauté, Diminution des conflits, Les parents sont engagés dans l'éducation des filles et garçons, Présence des AGR et AVEC pour la relance économique.
Description du rapport homme-femme	Les travaux se font déjà en groupe homme-femme, d'autres femmes encore entreprennent et s'occupent de la survie de leurs familles.
3. Soutien et limites de l'APC au niveau de la communauté	
Accompagnement des chefs	Sensibilisation de la communauté à rejoindre les ateliers, Sensibilisation des survivantes de viols à recourir à la justice.
À faire pour rendre ces ateliers plus solides	Vulgariser les informations des ateliers à l'ensemble de la communauté et des familles.

3.1.3. Récits de vie dans les deux sites d'intervention

Tableau 3 : Résultats de récits de vie dans les deux sites d'intervention

	Verbatim des récits de vie	
Guides	**Femme**	**Homme**
	SOSAME	
Situation initiale dans le milieu	« J'étais une grande femme débrouillarde avec 9 enfants et autour de 15 petits fils ». « Je vendais des bétails, mes produits de récolte et nous vivions en paix, certes il y avait de petites tracasseries, mais on était là ».	« Nous vivions en paix dans notre famille, certes certaines difficultés de la vie ». « J'étais élevé par mon oncle paternel. Celui qui répondait à tous mes besoins ». « il était un père pour moi ».
Élément modificateur	« En de 1996 à 2006, j'ai assisté à des évènements cruels ». « Les gens ont été égorgés à couteaux, par des machettes comme des chèvres ».	« Nous avons connu la guerre entre les groupes Maïmaï et RCD ». « les Maïmaï ont tué mon oncle paternel qui était la personne qui subvenait à mes besoins ».
Événement vécu	« Ces images sont restées dans ma tête, je ne pouvais pas me rendre au marché ou sur les lieux publics car les images me revenaient toujours ». « Parfois je me réfugiais dans la forêt et je voyais les mêmes personnes avec des machettes et couteaux venir me chercher ». « Mon entourage ne pouvait pas m'approcher ».	« J'ai cherché de l'aide, je n'ai pas trouvé, j'ai jugé de rejoindre le groupe armé Maïmaï ». « Mon objectif était de tuer le commandant qui avait ordonné l'assassinat de mon oncle ». « Je n'ai pas atteint mon objectif ». « j'étais alors traumatisé par mon échec et je suis revenu dans notre communauté. Tout en étant militaire, j'ai commencé à voler, violé… Je commençais à prendre de la drogue ».
Rééquilibrant	« certains de mes proches qui connaissaient l'existence de SOSAME dans le milieu m'ont amené au centre de prise en charge ». « Les psychologues m'ont posé plusieurs questions, parfois je répondais et parfois non ». « Après deux mois de rendez-vous, les psychologues ont commencé à m'apprendre comment je peux me guérir moi-même ». « J'ai alors commencé mes ateliers sur le guérir ensemble en intégrant les groupes communautaires de SOSAME ».	« Un jour j'ai vu les psychologues de SOSAME en train de sensibiliser la communauté sur les violences ». « J'ai suivi sans toutefois m'identifier comme militaire, mais tout ce qu'ils ont dit m'a fortement touché ». « Un jour suis parti à MAZIBA où j'ai participé pour la première fois dans un atelier de sensibilisation, ils ont sensibilisé sur les violences et c'est ce jour-là que je me suis porté volontaire pour commencer les ateliers ». « Je suis passé par une évaluation de l'état psychologique avec l'équipe SOSAME ». « plusieurs jours après, ils ont commencé à rendre visite à ma famille et au chef du village ».
Changement observé (Situation finale)	« Je suis devenue personnes-ressources, chef d'un groupe solidaire et je commence à guérir les autres » « J'éduque les hommes et les femmes sur le guérir ensemble ». « j'ai repris mon travail de vendeuse ». « Je fais l'élevage de chèvres » « je réponds à mes besoins et ceux de ma famille ».	« C'est mon entourage (ma femme, les membres de la communauté et le chef) qui a témoigné mon changement à l'équipe SOSAME ». « Actuellement, je n'ai même pas un diplôme d'état, mais je suis personne ressources et cela me donne une certaine considération dans la communauté ». « J'ai construit ma maison, je fais l'élevage ».
Pérennisation des ateliers	« Nous avons déjà appris beaucoup et nous avons les moyens ». « Nous sommes prêts à animer ces ateliers ».	« Nous avons déjà des connaissances et nos AGR pour continuer nous même avec les ateliers ». « Si jamais l'État congolais nous le permet, nous sommes prêts à aider avec notre expérience ».

3.2. Résultats quantitatifs

3.2.1. Caractéristiques démographiques des enquêtés

La figure 1 repend les résultats sur l'âge des bénéficiaires de l'APC.

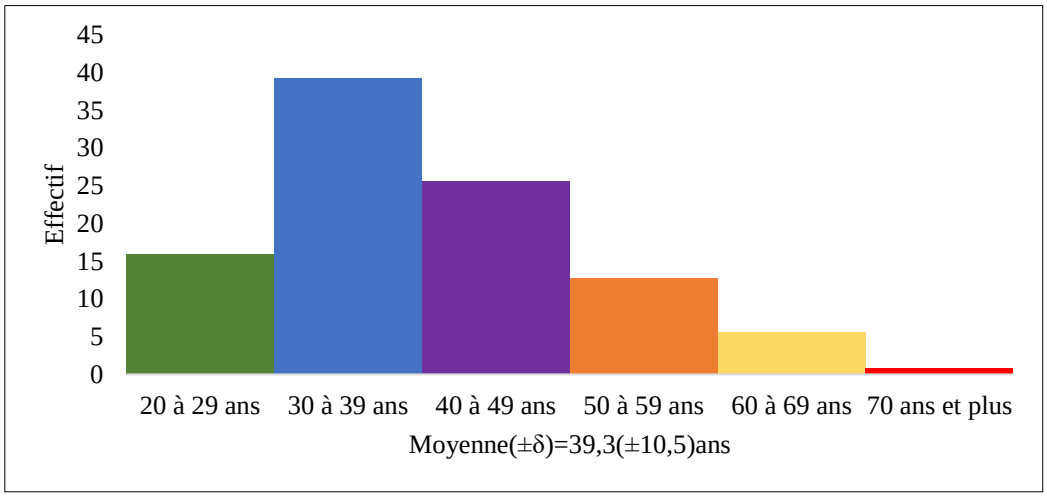

Fig. 1: Age des bénéficiaires de l'Approche Psychosociale Communautaire (APC)

Il en ressort de cette fifgure que l'âge moyen des bénéficiaires était de 39 ans (Fig.1).

La figure 2 repend les résultats sur le sexe, les niveaux d'études, et la religion des bénéficiaires de l'APC.

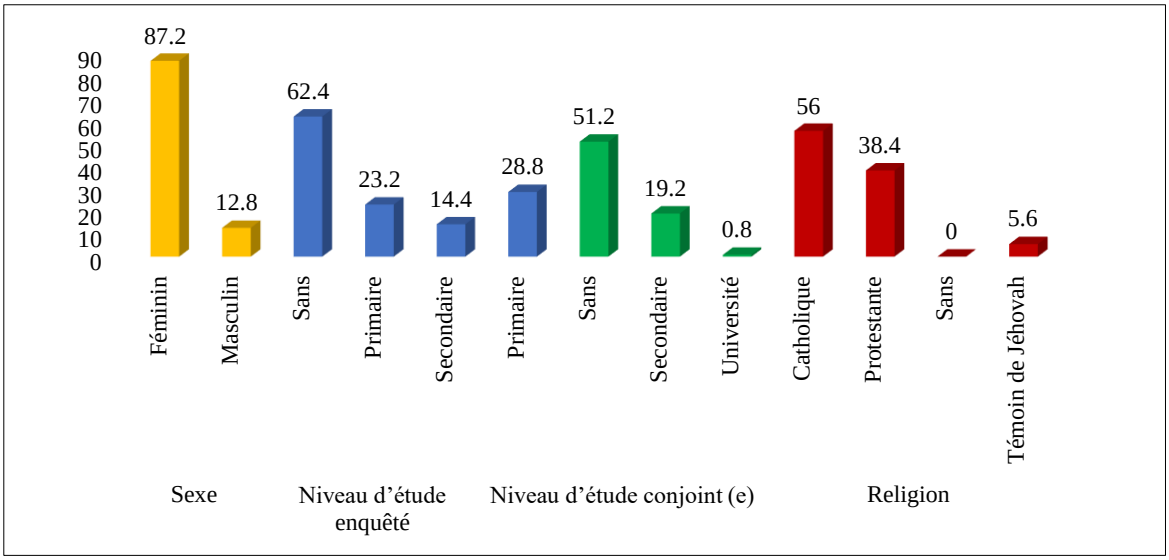

Fig. 2 : le sexe, les niveaux d'études, et la religion des bénéficiaires de l'APC

Les résultats ont enregistré une prédominance de sexe féminin. Les sans études étaient plus observés. La même situation était observée chez les conjoints. Plus de la moitié était de religion catholique (Fig.2).

3.2.2. Caractéristiques économiques des bénéficiaires de l'APC

La figure 3 présente les résultats sur les caractéristiques économiques des bénéficiaires de l'APC.

La majorité était des cultivateurs-éleveurs. Cette même situation s'est observée pour les conjoints(e) des enquêtés. L'agriculture était la source principale de revenu. Les mères prédominaient notre population d'étude.

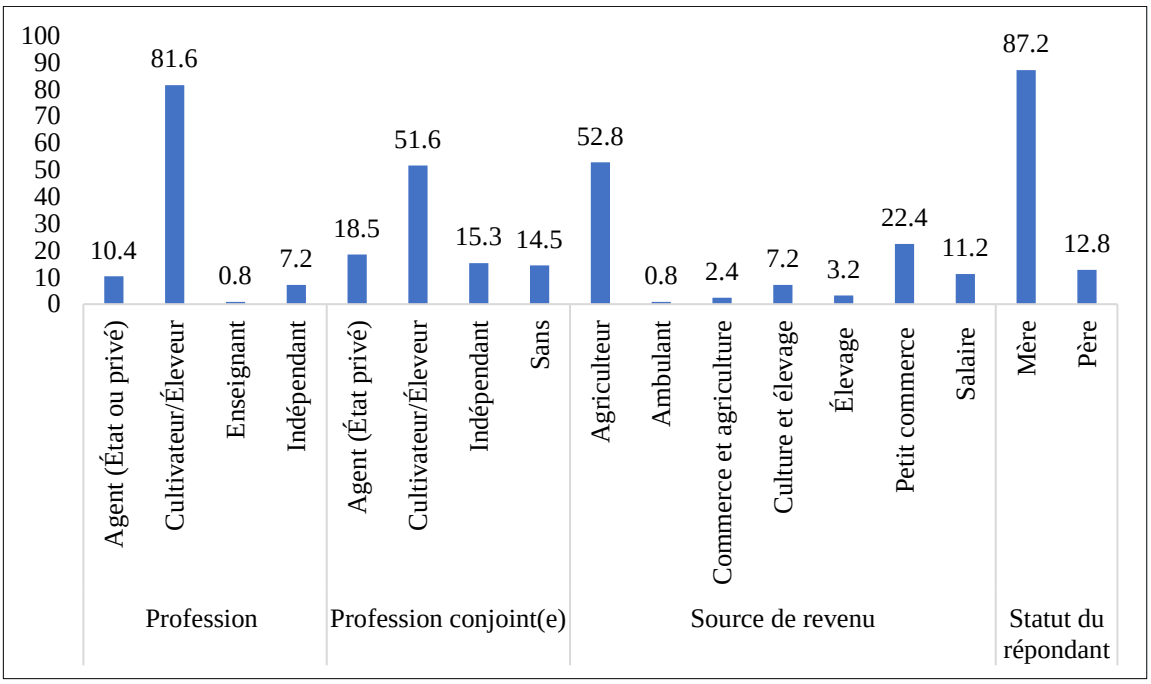

Fig. 3 : Caractéristiques économiques des bénéficiaires de l'APC

3.2.3. Début de l'intégration des ateliers et débuts de la sensibilisation

Plus de la moitié presque la moitié 41,6 % avait intégré les ateliers en 2017-2018 dans le site SOSAME. La sensibilisation était plus fréquente de 2020-2021 soit 50,4%. La majorité soit 76,8% a intégré les ateliers par la sensibilisation des membres de la communauté. Les autres ont été sensibilisés par l'organisation de mise en œuvre.

3.2.4. Normes culturelles, responsabilité dans la survenue des violences et la gestion des conflits

Les normes culturelles les plus connues sont l'exclusion de la femme à l'héritage et dans l'espace de prise de décision respectivement 44% et 42%. En plus, 73,6% reconnait une responsabilité partagée dans la survenue des violences. Plus de la moitié a déjà dénoncé un cas de violence soit 51,2%. La conscientisation, le deuil, le pardon et la réconciliation sont la manière de résoudre les conflits pour la majorité des bénéficiaires soit 86,4%. La majorité a déclaré que les victimes sont bien accueillies (88,8%), les enfants issus des viols sont bien encadrés (91,2%) et les violences ont diminué (99,2%).

3.2.5. Entraide et soutien moral dans la communauté.

La figure 4 reprend les résultats sur l'entraide et le soutien moral au sein de la communauté.

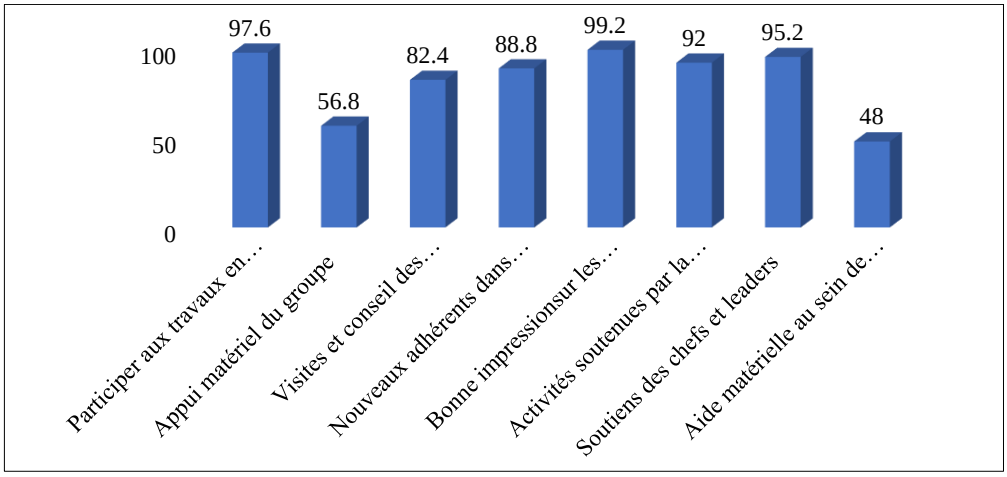

Fig. 4 : Entraide et le soutien moral au sein de la communauté

La majorité participait aux travaux en équipe et plus de la moitié reconnait avoir reçu un appui matériel au sein du groupe. Une grande partie a déjà reçu les visites et conseils du groupe et reconnait qu'il y a de nouveaux adhérents. L'impression de la communauté est très bonne par rapport au groupe, les activités sont soutenues par la majorité et les groupes ont le soutien des chefs et leaders au niveau de la communauté. Presque la moitié reconnait avoir reçu une aide de la part du groupe.

3.2.6. Comportement des partenaires au sein de couple

La figure 5 reprend les résultats sur le comportement des partenaires au sein du couple.

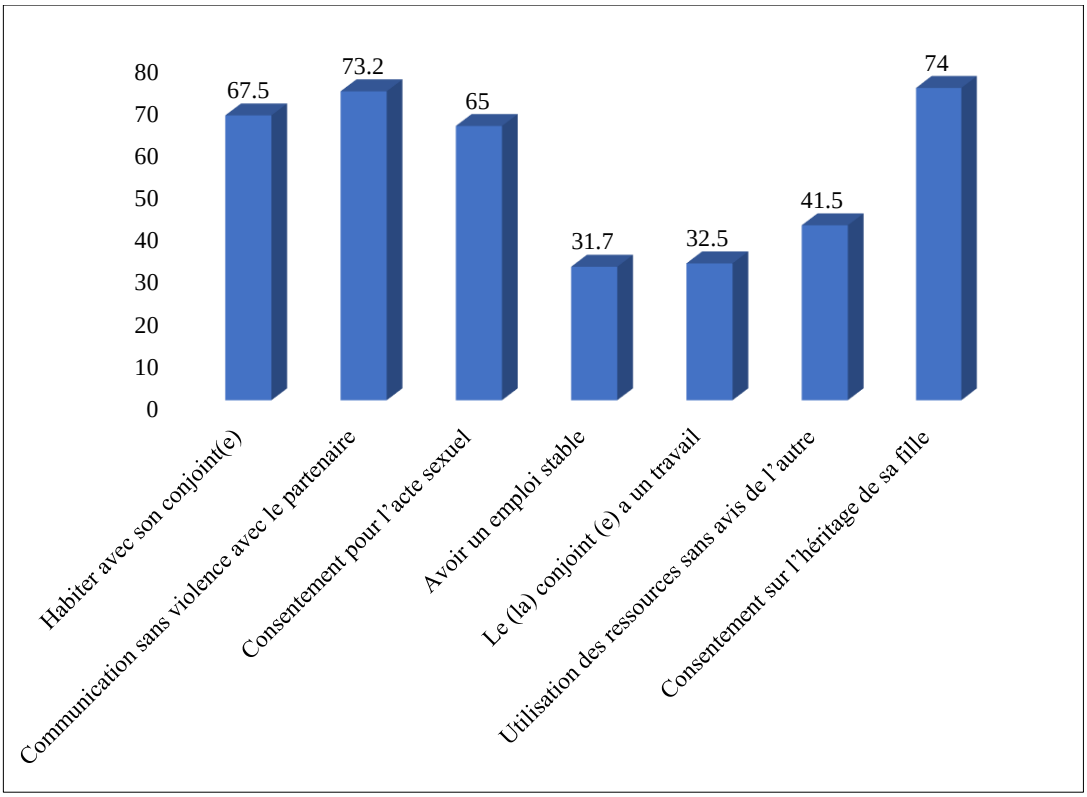

Fig. 5 : Comportement des partenaires au sein du couple

Plus de la moitié reconnait habiter sous le toit avec son conjoint. Une grande partie dit que le conjoint communique sans violence et demande son consentement lors de rapport sexuel. Plus de la moitié n'a pas d'emploi stable et le conjoint n'a pas du travail. Il ressort les partenaires n'utilisent pas les ressources encore sans avis de l'autre. Une grande partie consent que la fille puisse hériter les biens de la famille.

3.2.7. Partage des travaux au sein du ménage

La figure 6 reprend les résultats sur le partage des travaux au sein du ménage.

Sur les 13 critères mise en pale par notre questionnaire, le conjoint a réussi à partager faire plus de 7 taches sur 13 sans tenir compte de la division sexuelle du travail (Fig. 6).

3.2.8. Degré de satisfaction sur la médiation et la réconciliation dans la communauté

La gestion des problèmes: au sein de couple (98,4%) , de familles (96,8%), avec les voisins (98,4%), dans le groupe (99,2%) et au sein de la communauté (93,6%) sont bien appréciées dans deux sites. La cohabitation au sein du groupe est satisfaisante à 100%.

3.2.9. Développement social et psychologique dans population bénéficiaire

Les femmes participent plus dans les instances de prise de décision (76,8%), d'héritage (66,4%) et dans les activités féminines (95,2%). La plupart des bénéficiaires dit prêts à repartir à nouveau après les atrocités et ne se caractérisent pas par l'esprit de vengeance soit 97,6%.

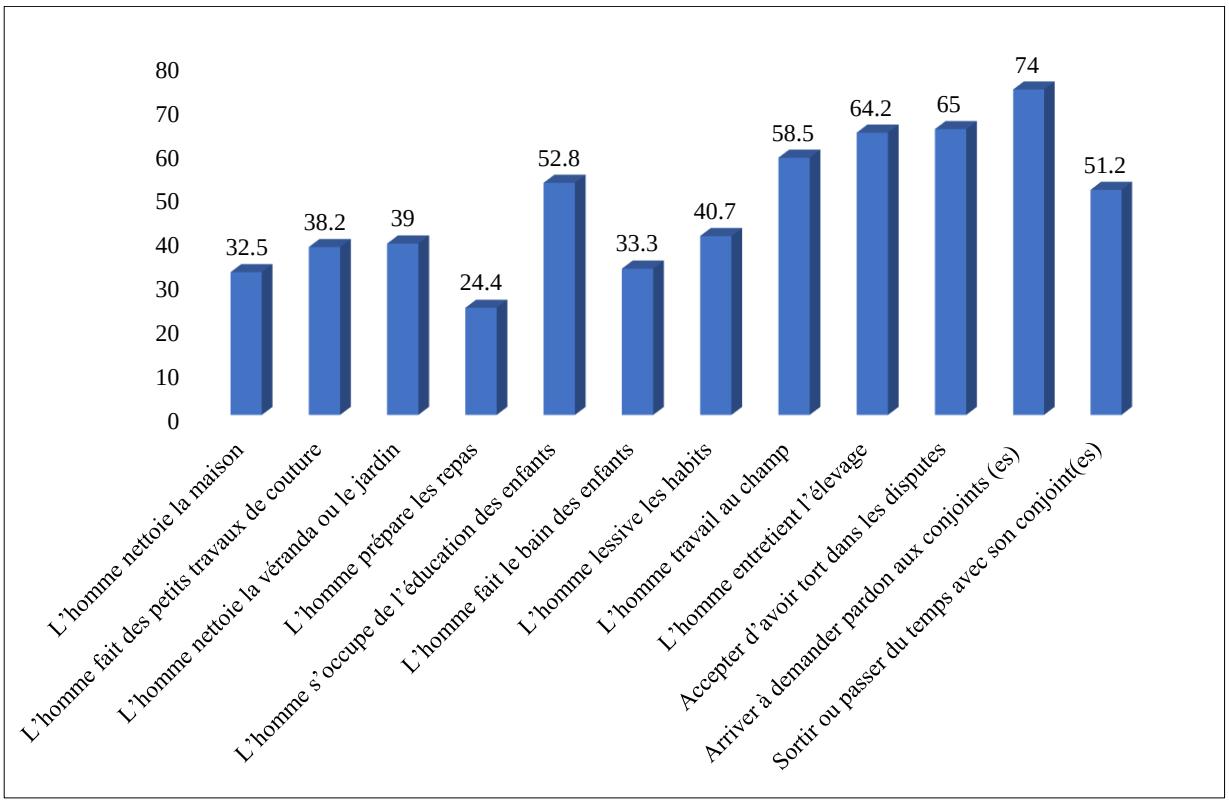

Fig. 6 : Partage des travaux au sein du ménage

3.2.10. Développement économique et culturel

Seul 41,6% des membres possèdent des Activités Génératrices des Revenus (AGR) en groupe et la majorité a déjà développé des AGR au niveau des ménages. Les femmes sont impliquées dans la gestion de l'économie de ménage soit 88,8%. Une grande partie estime que les faits discriminatoires sont encore visibles au sein de la communauté (72,8%), mais les bénéficiaires sont ouverts (personnellement) déjà à la collaboration intercommunautaire (89,6%). Presque la totalité des enquêtés accepte de prendre leur conjoint comme leur représentant en cas de nécessité (98,4%).

4. Discussion

4.1. De l'origine et des causes des violences sexuelles et basées sur le genre à l'Est de la RD Congo

Les résultats montrent que les violences existaient déjà, mais elles se sont accentuées avec les guerres de 1994-1996-1998 dans la région des Grands Lacs avec l'entrée à l'Est du pays des réfugiés armés. Cela a favorisé la prolifération des armes et a entraîné la présence des groupes armés et des rebelles. Bien que l'ensemble de la communauté soit touché, la vulnérabilité est disproportionnée, car les femmes et les filles sont les plus affectées. Dans son rapport sur la République démocratique du Congo, et en particulier la région orientale du pays, Human Rights recense les formes de violences vécues par les communautés, notamment les filles et les femmes, et souligne que la RDC est considérée comme la « capitale mondiale du viol » [11].

Au-delà des guerres à répétition, les résultats indiquent que certaines pratiques culturelles qui fragilisent la femme et constituent également un facteur favorisant les violences. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) appuie ces résultats en montrant que les femmes vivant dans la pauvreté représentent une proportion importante des victimes [9]. La forme la plus répandue est le viol des filles et des femmes. Les personnes interrogées ont souligné que cette situation a également des répercussions directes sur les enfants. Outre le viol, d'autres formes de violence sont fréquemment citées : mariages forcés, mariages précoces, enlèvements de femmes et de filles par les groupes armés, tortures, recrutement forcé dans les groupes armés, …. Une étude récente publiée dans l'*American Journal of Public Health* révèle que jusqu'à 1,8 million de femmes congolaises ont été violées au moins une fois dans leur vie [10].

Dans la vie civile, l'exposition continue des communautés à ces fléaux engendre des conflits communautaires et familiaux, des injures, des menaces de mort, des règlements de compte, de la justice populaire, des incitations à la violence, une sous-estimation des capacités des femmes (sur les plans social, culturel et économique). Dans sa thèse,

Olivia soutient ces résultats [12,13]. Dans la sphère conjugale, on observe des bagarres et des tortures, des injures, l'absence de consentement lors des rapports sexuels, le non-respect de la femme et le refus de lui accorder le contrôle des ressources du ménage. Nos résultats rejoignent la théorie de Johnson, qui, dans son article, propose trois types de violence conjugale : le terrorisme conjugal, la violence de résistance et la violence situationnelle. Il montre que les deux premiers types sont motivés par le contrôle et le pouvoir, tandis que le troisième découle de situations conflictuelles où la violence s'intensifie [14]. Certains enquêtés ont également évoqué le contrôle des ressources minières comme facteur explicatif des viols et violences dans la région. Jacquemot P, dans son article sur les ressources minérales, armes et violences dans les Kivus (RDC), soutient cette hypothèse [15].

Par ailleurs, la coutume contribue également aux violences à travers des pratiques discriminatoires à l'égard des femmes : interdiction d'hériter, de prendre la parole en présence des hommes, accès limité à l'éducation. Les influences culturelles étrangères qui échappent au contrôle parental et les conflits intergénérationnels sont également cités comme causes des violences. Ces résultats révèlent des causes plurielles (politiques, économiques, culturelles, sociales…). Gahama J, dans son article, montre que les violences dans la région des Grands Lacs sont de nature politique, économique, psychologique et socioculturelle [8].

Les auteurs des violences sont souvent des hommes armés, peu éduqués ou mal intentionnés. Au niveau communautaire, les auteurs se distinguent parfois par leur arrogance, leur influence au sein des leaders locaux ou de la justice. On observe également une tolérance culturelle face aux violences faites aux femmes (arrangements à l'amiable) et la stigmatisation des victimes. Durant A, dans son article, souligne que le système patriarcal constitue une oppression à l'égard des femmes [17].

4.2. Des blessures des violences sexuelles et basées sur le genre à l'Est de la RD Congo

Les survivants des violences présentent des symptômes tels que l'esprit de vengeance, la solitude, la colère, la honte, la culpabilité, des traumatismes pouvant aller jusqu'à la dépression ou au suicide. À l'échelle communautaire et familiale, on observe la rupture des relations affectives, la pauvreté, le manque de dialogue, la frustration des membres et la négligence de l'éducation des enfants. S'ajoutent également des pratiques telles que les appels à la vengeance, le recours à la sorcellerie et à la justice populaire dans ces communautés meurtries. Romito P et al. [18], Tankalalwa KD et al. [19], et Nancy G et al. [20] confirment ces résultats dans leurs études sur les conséquences des violences sur les femmes et les communautés.

4.3. Des attentes des communautés blessées et des changements observés suite aux ateliers

Pour la majorité des personnes enquêtées, la sensibilisation par d'autres membres a favorisé l'adhésion aux ateliers, dans le but de trouver un refuge pour guérir des blessures issues de leurs expériences. Pour d'autres encore, ces ateliers étaient une opportunité d'acquérir des connaissances sur les droits, la protection de la famille, des femmes et de la communauté aux plans social, culturel et économique. Les rapports des organisations et les résultats obtenus dans cette approche soutiennent ces observations [21,22]. Kathrin G., dans son rapport, met en évidence les attentes des communautés bénéficiant de l'Approche Psychosociale Communautaire [24]. Les changements observés sont multidimensionnels (économiques, culturels, sociaux, psychologiques, politiques et juridiques).

Sur le plan psychologique : les interviewés signalent la disparition des sentiments de vengeance, de solitude et d'instabilité. La fierté (chez auteurs et victimes) s'est installée. Les traumatismes et les communications violentes ont diminué. Gasibirege S. souligne que le processus de changement est complexe, mais que la gestion des émotions, le pardon et la reconstruction de la vie sont possibles grâce à l'aide mutuelle des membres [24].

Sur le plan économique : un esprit entrepreneurial s'est développé avec la création d'activités génératrices de revenus (AGR), des activités collectives et la mise en place d'associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) permettant aux membres de subvenir à leurs besoins. Sur le plan communautaire et social : la gestion des conflits, la médiation, la réconciliation, le dialogue et le conseil sont devenus des pratiques courantes. Les autorités ont confirmé la diminution des conflits et l'amélioration de la scolarisation des enfants des deux sexes.

Sur le plan culturel : les femmes participent à des activités autrefois réservées aux hommes, et inversement. Les rapports homme-femme évoluent. Une majorité de répondants indique cohabiter avec leur conjoint dans un climat de communication non-violente, de respect du consentement, de partage des décisions et des tâches domestiques. La

reconnaissance du droit d'héritage pour les filles progresse.

Sur le plan politique et juridique : les participants ont acquis des connaissances sur les droits humains et les droits des femmes. Les hommes impliquent désormais les femmes dans les prises de décision communautaires et dans la prévention des violences, témoignant de la prise en compte de la masculinité positive. Bien que certains responsables politico-administratifs déclarent ne pas connaître leur rôle dans ce modèle, les interviews confirment qu'ils soutiennent l'initiative et sensibilisent à leur tour d'autres membres de la communauté.

5. Conclusion

Cette étude met en lumière les effets transformateurs de l'approche psychosociale communautaire « Guérir ensemble » auprès des bénéficiaires dans les sites d'intervention SOSAME dans le territoire de Walungu à l'Est de la République Démocratique du Congo. Elle démontre combien cette approche constitue une réponse efficace pour la protection des femmes, des familles et pour le développement communautaire.

Au regard de ces résultats, nous recommandons à tous les intervenants et aux communautés de s'approprier cette approche pour renforcer la cohésion communautaire ; aux responsables politiques et décideurs d'envisager son institutionnalisation ; aux chercheurs de conduire des études approfondies pour valider scientifiquement cette approche et contribuer à la réduction durable des violences.

Remerciements : N/A

Conflit d'intérêt :
Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt.

Références bibliographiques

1. Mulumeoderhwa BA, Munva B, Macece E. Comportement de la femme rurale face aux violences domestiques, cas de la zone de santé rurale de Kabare. Recherche Africaine, L'Afrique et son vécu. 2015;40:60-70.
2. Programme des Nations Unies pour la population (UNPP). Démarche axée sur l'égalité des sexes dans les situations de conflit et après conflits. Manuel; p. 27.
3. Coopération Suisse (DDC). L'approche psychosociale communautaire comme moyen de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. La Suisse dans le monde; 2019. Disponible sur: https://www.eda.admin.ch/countries/rwanda/fr/home/actualite/nouveautes.html/content/countries/rwanda/fr/meta/news/2019/Juin/colloque---l-approche-psychosociale-communautaire-
4. Transcultural Psychosocial Organization (TPO). Plan quinquennal 2019-2023. RDC; 2018. Disponible sur: http://tpordc.org/doc/PLAN%20QUINQUINAL%202019%202023.pdf
5. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Rape: Weapon of war [archive]. Disponible sur: https://www.ohchr.org (consulté le 23 sept 2021).
6. Mukwege D. The Right Livelihood Award; 2013. Disponible sur: www.panzihospital.org
7. Gasibirege S. Comprendre les violences sexuelles massives et répétitives. Kigali: Institut Africain pour la Psychologie Intégrale; 2013.
8. Gahama J. Les causes des violences ethniques contemporaines dans l'Afrique des Grands Lacs : une analyse historique et socio-politique. Afrika Zamani. 2006;14:101-15.
9. Amnesty International. La pauvreté et la violence : un cercle vicieux. Dossier Papiers Libres; 2014. Disponible sur: https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-localement/agir-ecole/espace-enseignants/enseignement-secondaire/dossier-papiers-libres-2004-violences-femmes/article/3-5-la-pauvrete-et-la-violence-un-cercle-vicieux-4344
10. Peterman A. Estimates and determinants of sexual violence against women in the Democratic Republic of Congo. Am J Public Health. 2011;1060.
11. EAFORD Papers. Paper No. 26: Human Rights or Self-Righteousness? A critique of the Department of State's 1981 Country Report on Human Rights Practices in the State of Israel. 1981;17. Disponible sur: https://primarysources.brillonline.com/browse/human-rights-documents-online/eaford-papers-paper-no26-human-rights-or-selfrighteousness-a-critique-of-the-department-of-states-1981-country-report-on-human-rights-practices-in-the-state-of-israel-1981-17-pp;hrdhrd09480018
12. Olivia P. Développement socio-affectif des enfants exposés à la violence conjugale: une approche de la sécurité émotionnelle. Thèse de doctorat inédite. Toulouse: Université de Toulouse; 2015.
13. Olivia P, Zaouhe Gaudron C. De l'exposition à la violence conjugale à la maltraitance: effets sur le développement de l'enfant. In: Rouyer V, de Léonardis M, Safont-Mottay C, Huet-Gueye

M, éditeurs. Actes du 6ème Colloque du RIPSYDEVE. Actualités de la psychologie du développement et de l'éducation. Toulouse: Université Toulouse 2 – le Mirail; 2014. p. 128-135. Disponible sur: http://hal.archives-ouvertes.fr/RIPSYDEVE/fr

14. Johnson MP. A typology of domestic violence: intimate terrorism, violent resistance, and situational couple violence. Boston (MA): Northeastern University Press; 2008.
15. Jacquemot P. Ressources minérales, armes et violences dans les Kivus (RDC). Hérodote. 2009;3(134):38-62. Disponible sur: https://www.cairn.info/revue-herodote-2009-3-page-38.htm
16. Organisation des Nations Unies (ONU). Violences sexuelles en RDC : l'impunité doit cesser ! Kinshasa; 2016. Disponible sur: https://bice.org/fr/violences-sexuelles-rdc-l-impunite-doit-cesser/
17. Centre de Prévention des Violences (CPCP). Violences faites aux femmes. Disponible sur: https://www.cpcp.be/publications/violences-femmes/
18. Romito P, Pellegrini M, Marchand-Martin L, Saurel-Cubizolles MJ. L'impact des violences conjugales sur la santé psychologique des femmes. Empan. 2022;128(4):39-49. Disponible sur: https://www.cairn.info/revue-empan-2022-4-page-39.htm
19. Ntakalalwa KD, Mulumeoderhwa BA, et al. Impact des violences domestiques sur la santé mentale des femmes dans la zone rurale de santé de Kabare au Sud-Kivu. Rev Cent Rech Promot Santé. 2017;5(1):76-93.
20. Guerra NG, Dierkhising C. Les effets de la violence communautaire sur le développement de l'enfant. Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants; 2012. Disponible sur: https://www.enfant-encyclopedie.com/pdf/expert/violence-sociale/selon-experts/les-effets-de-la-violence-communautaire-sur-le-developpement-de
21. Organisation mondiale de la santé (OMS). Santé mentale des adolescents. Genève; 2021. Disponible sur: https://inee.org/sites/default/files/resources/Community-Based%20Approaches%20to%20MHPSS%20Programmes-%20A%20Guidance%20Note%20%28French%29.pdf
22. Aganze M. Mwenga : le RFDP présente les fondamentaux de l'approche psychosociale communautaire "guérir ensemble les blessures de la vie'' aux prestataires de services au sein des structures sanitaires de la zone de santé de Mwana. JamboRDC; 2023. Disponible sur: https://jambordc.info/mwenga-le-rfdp-presente-les-fondamentaux-de-l-approche-psychosociale-communautaire-guerir-ensemble-les-blessures-de-la-vie-aux-prestataires-de-service-au-sein-des-struct/
23. Kathrin G. Solidarité et guérison: de l'importance de la communauté dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Direction du développement et de la coopération (DDC). Rwanda; 2019.
24. Direction de développement et de coopération de la Suisse (DDC). Un seul monde déménage. Mogadiscio; 2023. Disponible sur: https://www.eine-welt.ch/fr/2023/edition-2/dossier-les-femmes-sont-plus-douees-pour-promouvoir-la-paix